

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA	Código: PRD-HC-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	--

PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA

1. OBJETIVO

Estandarizar el procedimiento para la apertura, diligenciamiento y registro inicial de la Historia Clínica en el consultorio psicológico, asegurando que la información recolectada sea veraz, completa, secuencial y cumpla con los estándares normativos de habilitación.

2. ALCANCE

Aplica a todo paciente nuevo que ingrese al consultorio para recibir atención psicológica, desde el momento de la identificación hasta el registro de la primera nota de evolución.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología Tratante.

4. MARCO NORMATIVO

- Resolución 1995 de 1999 (Normas para el manejo de la Historia Clínica).
- Resolución 3100 de 2019 (Estándares de Habilitación - Criterio de Historia Clínica).
- Ley 1090 de 2006 (Código Deontológico del Psicólogo).

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Identificación del Paciente: Solicitar el documento de identidad original. El número de identificación del paciente será el mismo número de su Historia Clínica.
- 5.2. Verificación de Consentimiento: Previo a cualquier registro clínico, verificar que el paciente (o su representante legal) haya firmado el Consentimiento Informado.
- 5.3. Diligenciamiento de Datos Sociodemográficos: Registrar de forma completa los datos básicos (nombre, edad, estado civil, ocupación, escolaridad, teléfono, dirección, contacto de emergencia).
- 5.4. Registro Clínico Inicial (Apertura): Documentar el motivo de consulta, antecedentes, examen mental básico y la impresión clínica inicial.

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA	Código: PRD-HC-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	--

- 5.5. Reglas de Diligenciamiento: Todo registro debe tener fecha y hora. La redacción debe ser clara, legible, sin tachones, enmendaduras ni espacios en blanco. No se deben utilizar siglas o abreviaturas que no estén estandarizadas oficialmente en el consultorio.

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- 100% de las Historias Clínicas con Consentimiento Informado firmado y anexo.
- Identificación unívoca (C.C., T.I., R.C.) asignada como número de expediente.
- Cero espacios en blanco, tachones o alteraciones en el registro de apertura.

Aprobó

Natalia Angel Usuga